Questions — rectos

Carte 01

Quelle différence essentielle distingue virus et bactéries ?

Carte 02

À quelle famille appartiennent Candida et Aspergillus ?

Carte 03

Que signifie le caractère opportuniste d'un agent ?

Carte 04

Comment définir un microbiote ?

Carte 05

Quels sont les deux éléments centraux d'une IAS ?

Carte 06

Pourquoi le repère de 48 heures ne prouve-t-il pas une IAS ?

Réponses — versos correspondants

Carte 02

Ce sont des champignons. Candida est une levure et Aspergillus une moisissure.

Carte 01

Le virus dépend de cellules hôtes. Une bactérie possède une organisation cellulaire propre.

Carte 04

C'est l'ensemble des micro-organismes d'un milieu donné. Leur présence n'équivaut pas à une infection.

Carte 03

Il profite de circonstances favorables. Immunodépression ou rupture de barrière peuvent permettre une infection.

Carte 06

L'incubation et le lien aux soins restent déterminants. La chronologie est un repère, pas une preuve isolée.

Carte 05

Le lien avec les soins et l'absence au début, y compris d'incubation. Le délai seul ne suffit pas.

Questions — rectos

Carte 07

Quel lien existe entre infection nosocomiale et IAS ?

Carte 08

Que comparent incidence et prévalence ?

Carte 09

Qu'est-ce qu'une infection d'origine endogène ?

Carte 10

Quels éléments faut-il relier dans une chaîne de transmission ?

Carte 11

Pourquoi entretenir le matériel partagé entre patients ?

Carte 12

Une bactérie dans les urines prouve-t-elle une infection à traiter ?

Réponses — versos correspondants

Carte 08

Nouveaux événements sur une période et événements présents à un moment donné. Dates et dénominateurs sont indispensables.

Carte 07

Une infection nosocomiale est une IAS acquise en établissement de santé. Les IAS ont un périmètre plus large.

Carte 10

Réservoir, sortie, transmission, entrée et hôte réceptif. La prévention peut agir sur plusieurs maillons.

Carte 09

L'agent vient du patient lui-même. Son microbiote peut atteindre un site normalement protégé.

Carte 12

Non. Le résultat s'interprète avec les signes, le site et les conditions du prélèvement.

Carte 11

Il peut assurer une transmission indirecte. L'hygiène des mains ne désinfecte pas le dispositif.

Questions — rectos

Carte 13

Pourquoi combiner plusieurs mesures de prévention ?

Carte 14

Que rechercher avant de maintenir une voie veineuse inutilisée ?

Carte 15

Quels types d'anomalies surveiller sur une VVP ?

Carte 16

Que faire devant une VVP douloureuse et résistante à l'injection ?

Carte 17

Pourquoi ne pas banaliser une infection locale sur cathéter ?

Carte 18

Pourquoi préparer le soin avant de commencer ?

Réponses — versos correspondants

Carte 14

Son indication réelle et les alternatives. Un dispositif sans bénéfice prolonge une exposition évitable.

Carte 13

Elles interrompent des maillons différents. Aucune mesure isolée ne compense toutes les autres défaillances.

Carte 16

Ne pas forcer, évaluer et alerter. Ces anomalies imposent de rétablir une administration sûre.

Carte 15

Douleur, rougeur, gonflement, fuite et fonctionnement inhabituel. Les signaler permet une évaluation précoce.

Carte 18

Pour limiter interruptions et croisements propre-sale. Chaque contact peut créer une nouvelle indication d'hygiène des mains.

Carte 17

Une diffusion sanguine et des localisations à distance sont possibles. La surveillance et l'alerte précoces comptent.

Questions — rectos

Carte 19

La vaccination dispense-t-elle des précautions standard ?

Carte 20

Comment distinguer bactéricide et bactériostatique ?

Carte 21

Quelles informations transmettre sur une VVP anormale ?

Carte 22

Un délai prévu suffit-il à garantir la sécurité d'un cathéter ?

Carte 23

Quelle est la portée des précautions standard ?

Carte 24

Quelles trois questions poser avant de choisir une protection ?

Réponses — versos correspondants

Carte 20

Le premier tue, le second inhibe la multiplication bactérienne. Ces effets dépendent des conditions considérées.

Carte 19

Non. Elle apporte une protection spécifique et complète les autres mesures.

Carte 22

Non. La surveillance et la nécessité du dispositif restent à réévaluer en continu.

Carte 21

Les signes, leur apparition et les actions effectuées. Des faits précis soutiennent l'évaluation de l'équipe.

Carte 24

Le soin, l'exposition et le circuit. Ces éléments guident une protection adaptée.

Carte 23

Tout patient, tout soin et tout lieu. Elles s'adaptent au risque prévisible du geste.

Questions — rectos

Carte 25

Quels sont les deux moments « avant » et le moment « après exposition biologique » ?

Carte 26

Pourquoi réaliser une hygiène des mains après l'environnement du patient ?

Carte 27

Quels prérequis retenir pour les mains avant les soins ?

Carte 28

Quelles conditions rendent une FHA correctement réalisable ?

Carte 29

Quelles trois zones vérifier pendant la friction des mains ?

Carte 30

Une FHA reste-t-elle suffisante après un contact avec le téléphone ?

Réponses — versos correspondants

Carte 26

Les surfaces peuvent contaminer les mains. Le patient n’a pas besoin d’avoir été touché directement.

Carte 25

Avant contact patient, avant geste aseptique et après risque biologique. Les moments se répètent selon la séquence.

Carte 28

Mains visiblement propres et sèches, surfaces couvertes et durée respectée. Frictionner jusqu’au séchage complet.

Carte 27

Avant-bras dégagés, ongles courts sans vernis ni résine et absence de bijoux. La technique doit atteindre toutes les zones.

Carte 30

Pas pour le geste aseptique suivant. Ce contact peut recontaminer les mains.

Carte 29

Pouces, espaces interdigitaux et pulpes avec ongles. Une couverture complète dépend aussi des mouvements.

Questions — rectos

Carte 31

Quel principe détermine le port de gants non stériles ?

Carte 32

À quels moments changer ou retirer les gants ?

Carte 33

Quand un gant stérile perd-il sa stérilité ?

Carte 34

Comment choisir entre tablier et surblouse ?

Carte 35

Quelles protections prévoir contre une projection biologique au visage ?

Carte 36

Quels trois réflexes associer face à une toux ?

Réponses — versos correspondants

Carte 32

Après la tâche, entre patients et du sale vers le propre. Leur maintien peut déplacer la contamination.

Carte 31

L'exposition prévisible, notamment biologique ou à une muqueuse. Le diagnostic seul ne constitue pas l'indication.

Carte 34

Selon l'étendue et l'intensité de l'exposition. La protection se retire à la fin de la séquence prévue.

Carte 33

Lors d'un contact non stérile. Il faut rétablir les conditions d'asepsie avant de poursuivre.

Carte 36

Masque adapté, mouchoir ou haut du bras et hygiène des mains. Ils limitent émissions et transfert par contact.

Carte 35

Un masque et une protection oculaire adaptés. Les lunettes de vue ne remplacent pas une protection de soin.

Questions — rectos

Carte 37

Quels trois moyens matériels ou organisationnels préviennent les AES ?

Carte 38

Quelle priorité associer aux premiers soins d'un AES ?

Carte 39

Quels principes sécurisent linge sale et prélèvements ?

Carte 40

Pourquoi ne pas classer tous les déchets de soins en DASRI ?

Carte 41

Pourquoi la douchette ne remplace-t-elle pas le traitement des bassins ?

Carte 42

Quelle conduite tenir si le matériel de traitement des excreta est indisponible ?

Réponses — versos correspondants

Carte 38

Contacter sans délai le circuit médical prévu. Un éventuel traitement post-exposition est urgent.

Carte 37

Collecteur proche, remplissage respecté et dispositifs sécurisés. Éviter les manipulations d'aiguilles usagées.

Carte 40

Leur nature et leurs risques diffèrent. Les perforants, médicaments et produits chimiques suivent les filières prévues.

Carte 39

Conditionnement adapté et séparation du propre et du sale. L'extérieur des contenants doit rester maîtrisé.

Carte 42

Signaler et utiliser l'alternative validée. Une panne ne justifie pas une procédure contaminante improvisée.

Carte 41

Elle disperse les souillures sans garantir le traitement. Employer le circuit d'excreta prévu.

Questions — rectos

Carte 43

Quel est le rapport entre PS et précautions complémentaires ?

Carte 44

Quels trois éléments organiser en précautions contact ?

Carte 45

Un patient en précautions contact peut-il quitter sa chambre pour un soin ?

Carte 46

Une BMR est-elle nécessairement plus virulente ?

Carte 47

Un portage de BMR équivaut-il à une infection ?

Carte 48

Que signifient EPC et ERG ?

Réponses — versos correspondants

Carte 44

Chambre et sanitaires, matériel, information des équipes. Ils complètent les mains et les protections adaptées.

Carte 43

Les secondes s'ajoutent aux premières. Elles ne remplacent pas le socle de tous les soins.

Carte 46

Non. La multirésistance concerne les antibiotiques, pas automatiquement la virulence ou la FHA.

Carte 45

Oui, avec un déplacement organisé. Mains, tenue, lésions et information de l'accueil doivent être adaptés.

Carte 48

Entérobactérie productrice de carbapénémase et entérocoque résistant aux glycopeptides. Ce sont des exemples centraux de BHRe.

Carte 47

Non. La présence sans infection clinique n'impose pas à elle seule une antibiothérapie.

Questions — rectos

Carte 49

Comment une exposition antibiotique peut-elle sélectionner des résistances ?

Carte 50

Quel est le rôle d’un antibiogramme ?

Carte 51

Comment exploiter une alerte de résistance dans le dossier ?

Carte 52

Qu’est-ce qui conditionne la protection attendue d’un FFP2 ?

Carte 53

Comment distinguer isolement septique et environnement protecteur ?

Carte 54

Le nom Klebsiella pneumoniae impose-t-il des précautions air ?

Réponses — versos correspondants

Carte 50

Étudier la sensibilité bactérienne aux antibiotiques. Son interprétation ne remplace pas le contexte clinique.

Carte 49

Elle défavorise les bactéries sensibles. Des résistantes peuvent persister puis diffuser.

Carte 52

Son indication et son ajustement correct. Filtrer ne suffit pas si l'air contourne le dispositif.

Carte 51

Lire le germe, le site, la date et les consignes. L'équipe d'hygiène aide à interpréter la situation actuelle.

Carte 54

Non. Le site, le mode de transmission et le contexte guident les mesures.

Carte 53

Limiter la diffusion depuis une personne ou limiter l'exposition d'un patient fragile. Les objectifs peuvent coexister.

Questions — rectos

Carte 55

Que signifie asepsie lors d'un soin ?

Carte 56

Sur quels supports réalise-t-on antisepsie et désinfection ?

Carte 57

Pourquoi la famille d'un antiseptique ne suffit-elle pas au choix ?

Carte 58

Deux présentations d'une même marque sont-elles interchangeables ?

Carte 59

Quels critères vérifier pour un antiseptique chez le nouveau-né ?

Carte 60

Comment clarifier une allergie dite « à l'iode » ?

Réponses — versos correspondants

Carte 56

Tissus vivants pour l'antisepsie, milieu inerte pour la désinfection. Les produits ne sont pas interchangeables.

Carte 55

Empêcher l'introduction de micro-organismes dans le site protégé. Mains, matériel et technique participent ensemble.

Carte 58

Pas automatiquement. Forme lavante, aqueuse et alcoolique peuvent avoir des usages différents.

Carte 57

La formulation, la concentration et le site comptent aussi. Une même famille n'autorise pas tous les usages.

Carte 60

Identifier le produit et la réaction puis faire évaluer. Fruits de mer et contraste ne prouvent pas toute allergie iodée.

Carte 59

Âge, maturité cutanée, site et présentation. Une procédure spécifique évite de transposer celle de l'adulte.

Questions — rectos

Carte 61

Une peau propre est-elle déjà préparée pour tout geste invasif ?

Carte 62

Que faire avant l'antisepsie d'une peau visiblement souillée ?

Carte 63

Pourquoi respecter le séchage spontané d'un antiseptique ?

Carte 64

Peut-on compléter un flacon antiseptique déjà ouvert ?

Carte 65

Pourquoi désinfecter une valve avant sa manipulation ?

Carte 66

Que faire après une recontamination possible du site préparé ?

Réponses — versos correspondants

Carte 62

Nettoyer, rincer si nécessaire puis sécher. La souillure compromet les conditions de préparation.

Carte 61

Non. La propreté visible ne remplace pas l'antisepsie lorsque le geste la requiert.

Carte 64

Non, même avec le même lot. L'ouverture et la durée d'emploi doivent rester maîtrisées.

Carte 63

Il fait partie de la méthode d'application. Essuyer ou souffler compromet les conditions du soin.

Carte 66

Rétablir les conditions d'asepsie avant de poursuivre. L'absence de trace visible ne garantit pas la sécurité.

Carte 65

C'est un point d'accès critique potentiellement contaminé. La méthode doit respecter le dispositif et le séchage.

Questions — rectos

Carte 67

Que signifie le symbole « deux barré » d'un dispositif ?

Carte 68

Quel site définit un DM non critique ?

Carte 69

Comment reconnaître la destination critique d'un dispositif ?

Carte 70

Que vérifier pour le retraitement d'un DM thermosensible ?

Carte 71

Pourquoi vérifier le spectre d'un produit de traitement ?

Carte 72

Pourquoi prétraiter un DM souillé immédiatement ?

Réponses — versos correspondants

Carte 68

La peau intacte. Le dispositif reste soumis à un entretien compatible avec son utilisation.

Carte 67

Usage unique pour un patient. Son statut n'est pas modifié par un nettoyage ou une désinfection.

Carte 70

Destination, notice et procédé validé, y compris pour les accessoires. La thermosensibilité seule ne suffit pas.

Carte 69

Il accède à un tissu stérile ou au système vasculaire. Son traitement relève d'un circuit validé adapté.

Carte 72

Pour éviter le séchage, réduire la charge et faciliter le nettoyage. Cela ne le rend pas prêt à l'emploi.

Carte 71

Les agents n'ont pas la même résistance. Le procédé doit répondre à l'objectif dans ses conditions d'emploi.

Questions — rectos

Carte 73

Pourquoi le nettoyage précède-t-il le traitement final ?

Carte 74

Comment entretenir un appareil non immersible ?

Carte 75

Quels paramètres vérifier lors de la préparation d'un bain ?

Carte 76

Comment distinguer réduction logarithmique et assurance de stérilité ?

Carte 77

Que vérifier avant d'utiliser un matériel conditionné stérile ?

Carte 78

À quoi sert la traçabilité après traitement d'un DM ?

Réponses — versos correspondants

Carte 74

Par la méthode compatible prévue, souvent un essuyage adapté. Ni immersion ni pulvérisation directe ne s'improvisent.

Carte 73

Les souillures peuvent faire obstacle au procédé. Le traitement doit atteindre toutes les zones requises.

Carte 76

L'une décrit une diminution de population, l'autre une probabilité résiduelle. Ce ne sont pas deux comptages équivalents.

Carte 75

Dilution, température, durée et état de la solution. Les valeurs sont propres au produit et au procédé.

Carte 78

Retrouver dispositif, opérations et patient si nécessaire. Elle complète les contrôles sans remplacer le traitement.

Carte 77

Intégrité, sécheresse, identification et péremption. La conservation dépend du conditionnement et du circuit.

Questions — rectos

Carte 79

Quel est le but de la progression du propre vers le sale ?

Carte 80

La marche en avant se limite-t-elle à l'ordre des chambres ?

Carte 81

Pourquoi adapter le bionettoyage au secteur ?

Carte 82

Un petit travail de maintenance peut-il exposer à des spores ?

Carte 83

Pourquoi les travaux sont-ils préoccupants chez un patient immunodéprimé ?

Carte 84

Que faire si un confinement de chantier est rompu ?

Réponses — versos correspondants

Carte 80

Non. Elle organise les flux pour empêcher le croisement du sale vers le propre.

Carte 79

Éviter de recontaminer les zones traitées. La méthode doit maîtriser les flux et les outils utilisés.

Carte 82

Oui. Le risque dépend des poussières produites, pas seulement de la taille ou durée du chantier.

Carte 81

Activités, surfaces et vulnérabilité diffèrent. Une pratique locale ne devient pas une règle universelle.

Carte 84

Éviter le passage exposant et signaler. Les barrières et circuits doivent être rétablis par l'organisation prévue.

Carte 83

Ils peuvent disperser des spores inhalées. Le terrain favorise notamment des infections fongiques invasives graves.

Questions — rectos

Carte 85

Quelles trois voies d'exposition à une eau contaminée distinguer ?

Carte 86

Quelle exposition respiratoire relie eau et légionellose ?

Carte 87

Quels trois facteurs surveiller dans un réseau d'eau ?

Carte 88

Une purge suffit-elle à lever une restriction sur l'eau ?

Carte 89

Que transmettre face à une anomalie d'eau ?

Carte 90

Quel risque immédiat ajoute un traitement thermique du réseau ?

Réponses — versos correspondants

Carte 86

L’inhalation d’un aérosol contaminé. Cela ne préjuge pas des autres usages autorisés de cette eau.

Carte 85

Digestive, respiratoire par aérosol et contact cutanéo-muqueux. L’usage et le terrain déterminent la prévention.

Carte 88

Non. La remise en service dépend des mesures et contrôles prévus, pas du seul écoulement.

Carte 87

Stagnation, dépôts et températures favorables. La maîtrise du réseau doit être organisée et contrôlée.

Carte 90

La brûlure par eau chaude. Informer, sécuriser les points et attendre une remise en service autorisée.

Carte 89

Aspect, température, débit et point concerné. Des observations précises permettent une évaluation du réseau.

Questions — rectos

Carte 91

Après un soin sale, comment accéder au matériel propre ?

Carte 92

Quels temps précèdent l'administration sur une VVP en place ?

Carte 93

Quelle étape démarre immédiatement après usage d'un endoscope ?

Carte 94

Pourquoi classer séparément l'endoscope et ses accessoires ?

Carte 95

Que signifie l'absence d'alerte informatique chez une personne qui tousse ?

Carte 96

Quel point vérifier avant d'introduire du matériel chez un patient protégé ?

Réponses — versos correspondants

Carte 92

Mains, désinfection de l'accès, évaluation et rinçage prévu. Une voie déjà posée reste un accès à protéger.

Carte 91

Retirer les gants puis réaliser l'hygiène des mains requise. Traiter aussi les surfaces éventuellement contaminées.

Carte 94

Leur destination et leur statut peuvent différer. Un accessoire ne reprend pas automatiquement le circuit de l'appareil.

Carte 93

Le prétraitement selon sa procédure. Il prépare le nettoyage sans remplacer les étapes suivantes.

Carte 96

Son entretien compatible et les consignes de l'unité. Les EPI ne désinfectent pas l'objet introduit.

Carte 95

Elle n'exclut pas un risque. Les signes et le contexte guident les mesures initiales et leur réévaluation.

Questions — rectos

Carte 97

Que faire d'un sachet stérile tombé au sol avant le soin ?

Carte 98

Quels trois axes croiser avant un soin invasif ?

Carte 99

Pourquoi vérifier l'activité sur les virus nus ?

Carte 100

Pourquoi adapter les précautions contact à l'agent concerné ?

Carte 101

Quand mettre le FFP2 si des précautions air le requièrent ?

Carte 102

Quel contact caractérise un dispositif semi-critique ?

Réponses — versos correspondants

Carte 98

Patient et site, geste et produit, dispositif et circuit. La sécurité dépend de leur cohérence.

Carte 97

L'écarter et suivre la procédure de remplacement. L'apparence ne suffit pas à garantir la stérilité conservée.

Carte 100

Spores, parasites et bactéries n'ont pas les mêmes caractéristiques. Les mains, produits et circuits suivent les consignes spécifiques.

Carte 99

Ils peuvent être plus résistants à certains procédés. Le spectre du produit doit correspondre à l'objectif.

Carte 102

Une muqueuse ou une peau non intacte. Son traitement dépend ensuite du dispositif et du circuit validé.

Carte 101

Avant l'entrée, avec ajustement correct. La protection doit précéder l'exposition.

Questions — rectos

Carte 103

Quelle différence retenir entre Pontiac et maladie des légionnaires ?

Carte 104

Un filtre terminal autorise-t-il tous les usages de l'eau ?

Carte 105

Colonisation et infection : quelle différence ?

Carte 106

Une IAS est-elle toujours nosocomiale ?

Carte 107

Pourquoi retirer une sonde dès que possible ?

Carte 108

Sonde urinaire : extraluminal ou endoluminal ?

Réponses — versos correspondants

Carte 104

Non. Adaptation, échéance, terrain et usages autorisés restent à vérifier.

Carte 103

Forme non pneumonique bénigne et pneumonie potentiellement grave. Le terrain contribue à la gravité.

Carte 106

Non. Une IAS peut survenir après des soins à domicile ou en structure médico-sociale ; une infection nosocomiale est acquise en établissement de santé.

Carte 105

La colonisation n'entraîne pas de maladie attribuable ; l'infection implique une interaction pathogène. Un patient colonisé peut transmettre des germes.

Carte 108

Extraluminal : migration externe depuis le méat. Endoluminal : contamination de la lumière, notamment après rupture du circuit.

Carte 107

Le risque augmente avec la durée. Réévaluer quotidiennement l'indication permet de limiter l'exposition inutile.

Questions — rectos

Carte 109

Où placer le collecteur urinaire ?

Carte 110

Quel mécanisme explique de nombreuses pneumonies du patient ventilé ?

Carte 111

Ballonnet d'intubation : quelle unité retenir ?

Carte 112

Quelles sont les trois profondeurs d'ISO ?

Carte 113

Fenêtre de surveillance et infection tardive : quelle distinction ?

Carte 114

Pourquoi surveiller aussi après la sortie ?

Réponses — versos correspondants

Carte 110

La micro-inhalation de sécrétions colonisées, favorisée par l'altération des protections et les dispositifs.

Carte 109

Sous la vessie, sans contact avec le sol, avec un drainage libre de coudure et sans traction.

Carte 112

Superficielle, profonde et organe/espace. Elles ne correspondent pas au seul aspect de la peau.

Carte 111

Le repère habituel de 20–30 s'exprime en cmH2O, avec contrôle selon dispositif et protocole ; ne pas le remplacer par mmHg.

Carte 114

Une ISO peut se révéler au domicile ; le patient doit connaître les signes d'alerte et savoir qui contacter.

Carte 113

Les fenêtres standardisent le recueil ; elles n'interdisent pas le diagnostic d'une infection survenant plus tard.

Questions — rectos

Carte 115

Pourquoi le PICC est-il central ?

Carte 116

À quoi servent les hémocultures appariées ?

Carte 117

Comment la vaccination prépare-t-elle une réponse secondaire ?

Carte 118

Qu'est-ce que l'immunogénicité ?

Carte 119

Pourquoi les vivants posent-ils problème chez certains immunodéprimés ?

Carte 120

L'ARNm vaccinal devient-il une modification du génome ?

Réponses — versos correspondants

Carte 116

À comparer les résultats de la voie centrale et d'une veine périphérique ; une avance centrale d'au moins deux heures soutient le rôle du cathéter, sous conditions.

Carte 115

Son extrémité se trouve dans une veine centrale, même si son insertion se fait dans une veine périphérique du bras.

Carte 118

La capacité d'un antigène ou vaccin à provoquer une réponse immunitaire.

Carte 117

Elle induit une première réponse et des lymphocytes mémoire, mobilisables plus rapidement lors d'une rencontre ultérieure.

Carte 120

Il est une instruction temporaire traduite dans le cytoplasme puis dégradée ; il n'a pas pour fonction de modifier l'ADN.

Carte 119

Leur réplication peut être insuffisamment contrôlée ; respecter les contre-indications et avis spécialisés.

Questions — rectos

Carte 121

À quoi sert un adjuvant vaccinal ?

Carte 122

Pourquoi ne pas compter sur les autres vaccinés contre le tétanos ?

Carte 123

Que calcule 1 − 1/R0 ?

Carte 124

Que faire devant un schéma incomplet ?

Carte 125

Être habilité à vacciner dispense-t-il de vérifier le patient ?

Carte 126

Quelles fausses contre-indications éviter ?

Réponses — versos correspondants

Carte 122

Le réservoir est environnemental ; la protection dépend de l'immunisation de la personne exposée.

Carte 121

À renforcer la réponse immunitaire à l'antigène ; il n'est pas présent dans tous les vaccins.

Carte 124

Vérifier l'historique et le calendrier courant, puis planifier le rattrapage ; il n'est généralement pas nécessaire de tout reprendre.

Carte 123

Un seuil théorique d'immunisation dans un modèle simple ; ce n'est pas une garantie de couverture suffisante dans toute population réelle.

Carte 126

Petit rhume et rhinite allergique ne sont pas automatiquement des contre-indications ; distinguer maladie aiguë importante et allergie sévère ciblée.

Carte 125

Non : indication, schéma, consentement, terrain, contre-indications, produit, dose et voie restent à contrôler.

Questions — rectos

Carte 127

Réaction locale et anaphylaxie : quelle différence ?

Carte 128

Pourquoi surveiller un vaccin après son autorisation ?

Réponses — versos correspondants

Carte 128

Pour détecter et analyser notamment les effets rares ou nouveaux en usage réel ; un signal n'est pas automatiquement une preuve causale.

Carte 127

La réaction locale reste limitée ; l'anaphylaxie est systémique, potentiellement respiratoire ou circulatoire et relève de l'urgence.